Doc ID REGU_200711_792

GlaxoSmithKline Artwork Information Panel	RSC A/W Version: 2
Item Number: 418535	
Market Trade Name: Cervarix	
Change Order Number: CO-17772	
Market or Pack Owner: *Biologicals-IVR-GEXP	
Manufacturing Site: GSK-BEL-Wavre-BEWAV	
No. of Colours: 3 (does NOT include varnish, if applicable)	
Colour Format: Spot	
List Colours: (Include sample in fields provided below; e.g. spot / spot-CMYK equivalent)	
P 190 / Varnish	P 222 / P 021 / ATT 222
Technical Drawing No.: (do NOT include drawing version number) BIO_DRW438	
Point of Sale Code No.: N/A	
Regional Service Centre: RSC-Verona-RSCV	
RSC Contact Name: Gilioli Lia	

180 mm Measuring Bar

IF a status identification banner DOES NOT appear on this document, THEN this document has NOT been printed from the Global Pack Management system.

Artwork copyright is the property of the GlaxoSmithKline Group of Companies
All suppliers providing a service to GSK for printed components of any description must ensure that they have a licence for all fonts / software used in conjunction with GSK artwork. The distribution and use of fonts / software without a license constitutes an intellectual property infringement. GSK will not accept any liability for the breach of third party intellectual property rights by printed component suppliers. The GSK certification / audit process requires suppliers to declare that they do not use unlicensed fonts / software and may require the supplier to produce evidence of such licence to GSK.

Biologicals Additional Information Panel
Material weight: Family 2
Folded dimensions: N/A
Perforation: N/A



IF a status identification banner DOES NOT appear on this document, THEN this document has NOT been printed from the Global Pack Management system.

GlaxoSmithKline Artwork Information Panel	No. of Colours: 3 (does NOT include varnish, if applicable)	Colour Format: Spot			
	List Colours: (include sample in fields provided; e.g. spot / spot-CMYK equivalent)	P Pr.BLK	P 190	P 222	ATT BLACK
Item Number: 418578					
Market Trade Name: Cervarix	Technical Drawing No.: BIO_DRW3 (do NOT include drawing version number)				
Change Order Number: CO-17876	Point of Sale Code No.: N/A				
Market or Pack Owner: *Biologicals-IVR-GEXP	Regional Service Centre: RSC-Verona-RSCV				RSC A/W Version: 1
Manufacturing Site: GSK-BEL-Wavre-BEWAV	RSC Contact Name: Gilioli Lia				

180 mm Measuring Bar

Artwork copyright is the property of the GlaxoSmithKline Group of Companies
All suppliers providing a service to GSK for printed components of any description must ensure that they have a licence for all fonts / software used in conjunction with GSK artwork. The distribution and use of fonts / software without a licence constitutes an intellectual property infringement. GSK will not accept any liability for the breach of third party intellectual property rights by printed component suppliers. The GSK certification / audit process requires suppliers to declare that they do not use unlicensed fonts / software and may require the supplier to produce evidence of such licence to GSK.

Biologicals Additional Information Panel
Material weight: N/A
Folded dimensions: N/A
Perforation: N/A

17/D17







17/D17

NHÃN PHỤ

CÔNG TY GLAXOSMITHKLINE PTE LTD
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUY CÁCH: HỘP 1 BƠM TIÊM ĐƠN LIỀU 0,5ML

0,5ml/1liều/1 bơm tiêm đóng sẵn.
Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn. Hỗn dịch để tiêm.
SĐK:xxxx-xxxxx-xx. Số lô SX: xem LOT; NSX, HD (01/xx/xx): xem thêm MFD, EXP trên bao bì.
Sản xuất tại Bỉ. Bảo quản 2°C-8°C, tránh ánh sáng. Không để đông đá.
CĐ, CCĐ, cách dùng, đường dùng và thông tin khác: xem tờ hướng dẫn sử dụng.

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Doc ID REGU_200711_780 2

GlaxoSmithKline Artwork Information Panel	RSC A/W Version: 4
Item Number: 418575	
Market Trade Name: Cervarix	
Change Order Number: CO-17772	
Market or Pack Owner: *Biologicals-IVR-GEXP	
Manufacturing Site: GSK-BEL-Wavre-BEWAV	
No. of Colours: 3 (does NOT include varnish, if applicable)	
Colour Format: Spot	
List Colours: (Include sample in tube provided below; e.g. spot / spot+CMYK equivalent)	P 190 / P 222 / P 021 / ATT 222 / Varnish
Technical Drawing No.: (do NOT include drawing version number)	BIO_DRW411
Point of Sale Code No.:	N/A
Regional Service Centre:	RSC-Verona-RSCV
RSC Contact Name:	Gilioli Lia

If a white identification barrier DOES NOT appear on this document, THEN this document has NOT been printed from the Global Pack Management system.

100 mm Measuring Bar

Artwork copyright is the property of the GlaxoSmithKline Group of Companies
All supplies providing a service to GSK for printed components of any description must ensure that they have a licence for all fonts / software used in conjunction with GSK artwork. The distribution and use of fonts / software without a licence constitutes an intellectual property infringement. GSK will not accept any liability for the breach of third party intellectual property rights by printed component suppliers. The GSK certification / audit process requires suppliers to declare that they do not use unlicensed fonts / software and may require the supplier to produce evidence of such licences to GSK.

Biologicals Additional Information Panel
Material weight: Family 3
Folded dimensions: N/A
Perforation: N/A

- Chỉ có 01 bộ nhãn
→ trả nhãn
- Chỉ trả HD SD T Việt

17/7/17

PHARMA CODE N° 78

418575

LOT/MFG/EXP

116ZW112
45815

Refer to leaflet before use
Consulter la notice avant utilisation
Antes de la utilización lease el instructivo anexo

Medicinal product subject to medical prescription
Médicament soumis à prescription médicale
Producto medicinal sujeto a prescripción médica

Keep out of reach and sight of children
Tenir hors de portée et de la vue des enfants
Mantengase fuera del alcance y de la vista de los niños

Protect from light
Protéger de la lumière
Proteger de la luz

Shake before use
Agiter avant emploi
Agitar antes de usar

Do not freeze
Ne pas congeler
No congelar

Storage/Cons.: +2°C/ +8°C

10 x 1 dose/dosis (0.5 ml)

10 Prefilled syringes (1 dose) + 10 needles
10 Seringues préremplies (1 dose) + 10 aiguilles
10 Jeringas prellenadas (1 dosis) + 10 agujas

Intramuscular use
Voie intramusculaire
Via intramuscular

Cervarix

Human Papillomavirus vaccine Types 16 and 18 (Recombinant, AS04 adjuvanted)
Vaccin Papillomavirus Humain Types 16 et 18 (Recombinant, avec adjuvant AS04)
Vacuna contra el virus del papiloma humano, tipos 16 y 18 (recombinante, con adyuvante AS04)

Suspension for injection/ Suspension injectable/ Suspensión inyectable

GlaxoSmithKline

1 dose/dosis (0.5 ml) contains/contient/contiene:

Human Papillomavirus type 16 L1 protein/ Protéine L1 du Papillomavirus Humain type 16/ Proteína L1 virus del papiloma humano tipo 16..... 20 µg

Human Papillomavirus type 18 L1 protein/ Protéine L1 du Papillomavirus Humain type 18/ Proteína L1 virus del papiloma humano tipo 18..... 20 µg

3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (MPL)/ 3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipide A (MPL)/ 3-O-desacil-4'-monofosforil lípido A (MPL)..... 50 µg

Aluminium hydroxide, hydrated/ Hydroxyde d'aluminium hydraté/ Hidróxido de aluminio hidratado..... 0.5 mg Al^{3+}

Inj./Inyec.: I.M.

10 x 1 dose/dosis (0.5 ml)

10 Prefilled syringes (1 dose) + 10 needles
10 Seringues préremplies (1 dose) + 10 aiguilles
10 Jeringas prellenadas (1 dosis) + 10 agujas

Intramuscular use
Voie intramusculaire
Via intramuscular

Cervarix

Human Papillomavirus vaccine Types 16 and 18 (Recombinant, AS04 adjuvanted)
Vaccin Papillomavirus Humain Types 16 et 18 (Recombinant, avec adjuvant AS04)
Vacuna contra el virus del papiloma humano, tipos 16 y 18 (recombinante, con adyuvante AS04)

Suspension for injection/ Suspension injectable/ Suspension inyectable

GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l'Institut 89
B-1330 Rixensart - Belgium
© 2006 GlaxoSmithKline group of companies
Cervarix is a trademark of the GlaxoSmithKline group of companies

CÔNG TY GLAXOSMITH KLINE PTE LTD
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

PHARMA CODE N° 78

IF a status identification banner DOES NOT appear on this document, THEN this document has NOT been printed from the Global Pack Management system.

GlaxoSmithKline Artwork Information Panel	No. of Colours: 3 (does NOT include varnish, if applicable)	Colour Format: Spot			
	List Colours: (include sample in fields provided; e.g. spot / spot-CMYK equivalent)	P Pr.BLK	P 190	P 222	ATT BLACK
Item Number: 418578					
Market Trade Name: Cervarix	Technical Drawing No.: BIO_DRW3 (do NOT include drawing version number)				
Change Order Number: CO-17876	Point of Sale Code No.: N/A				
Market or Pack Owner: *Biologicals-IVR-GEXP	Regional Service Centre: RSC-Verona-RSCV				RSC A/W Version: 1
Manufacturing Site: GSK-BEL-Wavre-BEWAV	RSC Contact Name: Gilioli Lia				

180 mm Measuring Bar

Artwork copyright is the property of the GlaxoSmithKline Group of Companies
All suppliers providing a service to GSK for printed components of any description must ensure that they have a licence for all fonts / software used in conjunction with GSK artwork. The distribution and use of fonts / software without a licence constitutes an intellectual property infringement. GSK will not accept any liability for the breach of third party intellectual property rights by printed component suppliers. The GSK certification / audit process requires suppliers to declare that they do not use unlicensed fonts / software and may require the supplier to produce evidence of such licence to GSK.

17/D17

Biologicals Additional Information Panel
Material weight: N/A
Folded dimensions: N/A
Perforation: N/A



NHÃN PHỤ

17/D17

QUY CÁCH: HỘP 10 BƠM TIÊM ĐƠN LIỀU 0,5ML

Kx **CERVARIX**
Vắc-xin phòng HPV tuýp 16 và 18 ở người
(Tái tổ hợp, chất bổ trợ AS04)
Thành phần: Một liều (0,5ml) chứa:

Protein L1 của Papillomavirus tuýp 16 ở người	20 mcg
Protein L1 của Papillomavirus tuýp 18 ở người	20 mcg
3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (MPL)	50 mcg
Hydroxide nhôm, hydrate hóa	0,5 mg Al^{3+}

Đóng gói: 0,5ml/1liều/1 bơm tiêm đóng sẵn.
Hộp 10 bơm tiêm đóng sẵn.
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:
Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng.
Lắc đều trước khi sử dụng. Tiêm bắp vào vùng cơ delta
Dạng bào chế: Hỗn dịch để tiêm.
SĐK:xxxx-xxxxx-xx.
Số lô SX: xem LOT
NSX, HD (01/xx/xx): xem thêm MFD, EXP trên bao bì.
Bảo quản: 2°C-8°C. Không để đông đá.
Sản xuất bởi: GlaxoSmithKline Biologicals S.A
89 Rue de l'Institut, B-1130 Rixensart, Bỉ
THUỐC BÁN THEO ĐƠN
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CÔNG TY GLAXOSMITHKLINE PTE LTD
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Rx

Cervarix™

THUỐC BÁN THEO ĐƠN

1. Tên sản phẩm

Cervarix™

Vaccine phòng virus Papillomavirus (HPV) tuýp 16 và 18 ở người
(tái tổ hợp, chất bổ trợ AS04).

2. Thành phần định tính và định lượng

Một liều (0,5ml) chứa:

Protein L1 của Papillomavirus tuýp 16 ở người[1]	20 microgram
Protein L1 của Papillomavirus tuýp 18 ở người[1]	20 microgram
3-*O*-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (MPL)[2]	50 microgram
Hydroxide nhôm, hydrate hóa[2]	0,5 milligram Al^{3+}

[1] Protein L1 dưới dạng các tiểu thể giống với virus nhưng không gây nhiễm (VLPs) được sản xuất bằng công nghệ tái tổ hợp ADN sử dụng hệ thống biểu thị Baculovirus.

[2] Hệ thống bổ trợ AS04 độc quyền của GlaxoSmithKline là phức hợp của hydroxide nhôm và 3-*O*-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (MPL) *(xem phần Cảnh báo và thận trọng đặc biệt và phần Đặc tính Dược lực học)*.

3. Dạng bào chế

Huyền dịch để tiêm.

Cervarix được bào chế dưới dạng hỗn dịch trắng đục. Trong quá trình bảo quản, có thể quan sát thấy tủa màu trắng với phần nước nổi không màu.

4. Đặc tính lâm sàng

4.1. Chỉ định điều trị

Cervarix là một vắc-xin phòng ngừa các tổn thương tiền ung thư ác tính và ung thư cổ tử cung gây ra bởi một số tuýp virus papiloma có khả năng gây ung thư ở người. Xin xem thêm phần "*Cảnh báo và thận trọng đặc biệt*" và phần "*Đặc tính dược lực học*" để có thêm thông tin quan trọng giúp hiểu rõ hơn chỉ định này.

Chỉ định được dựa trên bằng chứng về hiệu quả trên phụ nữ độ tuổi 15-25 sau khi tiêm chủng vắc-xin Cervarix và dựa trên tính sinh miễn dịch của vắc-xin ở các bé gái và phụ nữ ở độ tuổi 10-25 tuổi.

4.2. Liều lượng và cách dùng

Liều lượng

Liệu trình tiêm chủng cơ bản bao gồm 3 mũi tiêm.

17/1/17

Liệu trình tiêm chủng được khuyến cáo là 0, 1 và 6 tháng. Nếu cần thiết phải thay đổi lịch tiêm chủng, mũi thứ 2 có thể được tiêm vào thời điểm từ 1 đến 2,5 tháng sau mũi thứ nhất và mũi thứ 3 tiêm vào thời điểm từ 5 đến 12 tháng sau mũi thứ nhất.

Mặc dù sự cần thiết phải tiêm mũi nhắc lại hiện chưa được xác lập, đáp ứng nhắc lại được quan sát thấy sau khi tiêm liều thử thách *(Xem phần Dược lực học)*

Cách dùng

Cervarix được dùng để tiêm bắp vào vùng cơ delta *(Xem phần Cảnh báo và thận trọng đặc biệt và Tương tác thuốc và các dạng tương tác khác)*

4.3. Chống chỉ định

Không tiêm Cervarix cho các đối tượng được biết có quá mẫn với bất kỳ thành phần nào trong vaccine *(Xem phần Dạng bào chế và Thành phần tá dược)*.

Không được tiêm bắp Cervarix cho những người giảm tiểu cầu hoặc rối loạn đông máu do hiện tượng chảy máu có thể xuất hiện sau khi tiêm bắp ở những đối tượng này.

4.4. Cảnh báo và thận trọng đặc biệt

Thực hiện tiêm chủng theo thực hành lâm sàng tốt bằng cách hỏi tiền sử về sức khỏe (đặc biệt là các thông tin liên quan đến lần tiêm chủng trước đó và khả năng xuất hiện các tác dụng không mong muốn) và thăm khám lâm sàng.

Cũng như các vaccine dạng tiêm khác, nên có sẵn các các phương tiện theo dõi và điều trị thích hợp để phòng ngừa trường hợp phản vệ xuất hiện sau tiêm chủng, mặc dù hiếm gặp.

Có thể xuất hiện hiện tượng ngất xỉu sau hoặc thậm chí trước khi tiêm do phản ứng tâm lý đối với mũi tiêm. Điều quan trọng trong khi tiêm là nên chọn địa điểm thích hợp để tránh bị thương do ngất xỉu.

Cũng như các vaccine khác, nên trì hoãn tiêm vaccine Cervarix ở những người đang sốt cao cấp tính. Tuy nhiên, khi có biểu hiện nhiễm khuẩn nhẹ như cảm thì không cần phải trì hoãn tiêm chủng.

Không được tiêm Cervarix theo đường tĩnh mạch hoặc trong da. Chưa có dữ liệu nghiên cứu đối với đường tiêm dưới da của vaccine Cervarix.

Giống với hầu hết các loại vaccine, đáp ứng miễn dịch bảo vệ có thể không được tạo ra ở toàn bộ các đối tượng được tiêm chủng.

Cervarix là một vaccine dự phòng. Vaccine này không ngăn chặn được sự tiến triển của các tổn thương liên quan đến HPV đã hiện diện tại thời điểm tiêm vaccine.

Cervarix không tạo ra tác dụng bảo vệ đối với tất cả các tuýp HPV gây ung thư *(Xem phần Dược lực học)*

Tiêm chủng là biện pháp dự phòng ban đầu và không thay thế cho biện pháp sàng lọc cổ tử cung định kỳ (biện pháp dự phòng thứ phát) cũng như các cảnh báo về việc phơi nhiễm HPV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Chưa có dữ liệu về việc dùng Cervarix cho những đối tượng suy giảm miễn dịch như bệnh nhân nhiễm HIV hoặc bệnh nhân đang điều trị các thuốc ức chế miễn dịch. Đối với những bệnh nhân này, đáp ứng miễn dịch có thể không đạt được như mong muốn.

Khoảng thời gian bảo vệ chưa được xác định chính xác. Hiệu quả bảo vệ duy trì tới 6,4 năm sau liều tiêm chủng đầu tiên đã được đánh giá. Các nghiên cứu dài hạn đang tiếp tục được thực hiện để xác định khoảng thời gian bảo vệ *(Xem phần Dược lực học)*.

4.5. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác

CÔNG TY GLAXO SMITHKLINE PTE LTD
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

17/1/17

Sử dụng đồng thời với các vaccine khác

Cervarix có thể tiêm đồng thời với bất kỳ vaccine nào dưới đây: vaccine kháng nguyên bạch hầu-uốn ván-ho gà vô bào (dTpa), vaccine bại liệt bất hoạt (IPV), vaccine phối hợp dTpa-IPV, vaccine viêm gan A (bất hoạt) (HepA), vaccine viêm gan B (rDNA) (HepB) và vaccine phối hợp HepA-HepB

Tiêm Cervarix vào cùng một thời điểm với Twinrix (vaccine phối hợp HepA-HepB) cho thấy không có ảnh hưởng về mặt lâm sàng đối với đáp ứng sinh kháng thể của kháng nguyên HPV và viêm gan A. Hiệu giá kháng thể trung bình nhân của anti-HBs thấp hơn khi chỉ định tiêm đồng thời nhưng ý nghĩa lâm sàng của sự thấp hơn này chưa được quan sát thấy do tỷ suất bảo vệ huyết thanh không bị ảnh hưởng. Tỷ lệ các đối tượng đạt được mức anti-HBs ≥ 10mIU/ml là 98,3% khi tiêm vaccine đồng thời và 100% khi dùng Twinrix riêng lẻ.

Nếu tiêm Cervarix cùng lúc với các vaccine dạng tiêm khác, nên tiêm vào các vị trí khác nhau.

Sử dụng đồng thời với các biện pháp tránh thai nội tiết tố

Trong các nghiên cứu về hiệu quả trên lâm sàng, có gần 60% các phụ nữ được tiêm vaccine Cervarix đã sử dụng các thuốc tránh thai nội tiết tố. Không có bằng chứng nào cho thấy các thuốc tránh thai nội tiết tố có ảnh hưởng đến hiệu quả của Cervarix.

Sử dụng đồng thời với các thuốc ức chế miễn dịch toàn thân

Cũng giống với các vaccine khác, đáp ứng miễn dịch có thể không đạt được tối ưu ở những bệnh nhân đang sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch.

4.6. Sử dụng trong thai kỳ và cho con bú

Khả năng sinh sản

Xem "Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng".

Thai kỳ

Các nghiên cứu đặc hiệu về việc sử dụng vaccine trên phụ nữ có thai không được thực hiện. Trong chương trình phát triển thử nghiệm lâm sàng, các trường hợp có thai đã được báo cáo. Các số liệu này chưa đầy đủ để khuyến cáo sử dụng Cervarix trong thai kỳ. Do vậy, nên trì hoãn việc tiêm phòng vaccine cho đến khi kết thúc thai kỳ.

Ảnh hưởng của Cervarix đến sự sống và phát triển của phôi thai, trước và sau sinh đã được đánh giá trên chuột nhắt. Những nghiên cứu trên động vật đó không cho thấy ảnh hưởng bất lợi trực tiếp hay gián tiếp đến khả năng sinh sản, thai kỳ, sự phát triển của phôi/bào thai, quá trình sinh đẻ hoặc sự phát triển sau khi sinh.

Cho con bú

Ảnh hưởng đối với trẻ đang bú mẹ khi mẹ tiêm Cervarix chưa được đánh giá trong các nghiên cứu lâm sàng.

Chỉ nên sử dụng Cervarix trong thời gian cho con bú khi xét thấy lợi ích vượt trội so với nguy cơ có thể xảy ra.

Các dữ liệu huyết thanh học cho thấy kháng thể kháng HPV-16 và HPV-18 được truyền qua sữa trong thời kỳ cho con bú ở chuột nhắt. Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu kháng thể tạo thành sau tiêm chủng có được bài tiết qua sữa người hay không.

4.7. Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Chưa có các nghiên cứu về ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

4.8. Tác dụng không mong muốn

Dữ liệu nghiên cứu lâm sàng

CÔNG TY GLAXOSMITHKLINE PTE LTD
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

17/D17

Đã có nghiên cứu trên lâm sàng thực hiện trên 12.672 phụ nữ từ 10-25 tuổi. Các đối tượng này đã được theo dõi và đánh giá về tính an toàn sau tiêm vaccine.

Tác dụng không mong muốn phổ biến nhất được quan sát thấy sau tiêm chủng là đau tại chỗ tiêm với tỷ lệ là 78% trong tổng số các liều tiêm. Phần lớn các tác dụng không mong muốn này xảy ra ở mức độ nhẹ đến trung bình và không kéo dài.

Các tác dụng không mong muốn được cho là có khả năng liên quan đến việc tiêm chủng được liệt kê theo tần suất.

Tần suất được báo cáo như sau:

Rất phổ biến ≥1/10

Phổ biến ≥1/100 đến <1/10

Không phổ biến ≥1/1000 đến <1/100

Hiếm gặp ≥1/10000 đến <1/1000

Rất hiếm <1/10000

Không biết (không thể ước lượng từ các dữ liệu hiện có)

Nhiễm khuẩn và nhiễm ký sinh trùng

Không phổ biến: nhiễm khuẩn đường hô hấp trên

Rối loạn máu và hệ bạch huyết

Không phổ biến: sưng hạch bạch huyết

Rối loạn hệ thần kinh

Rất phổ biến: đau đầu

Không phổ biến: hoa mắt, chóng mặt

Rối loạn hệ tiêu hóa

Phổ biến: rối loạn hệ tiêu hóa bao gồm buồn nôn, nôn, tiêu chảy và đau bụng

Rối loạn da và mô dưới da

Phổ biến: ngứa, phát ban, mày đay

Rối loạn cơ xương và mô liên kết

Rất phổ biến: đau cơ

Phổ biến: đau khớp

Rối loạn toàn thân và tại chỗ tiêm

Rất phổ biến: phản ứng tại chỗ tiêm bao gồm đau, đỏ, sưng mệt mỏi

Phổ biến: sốt (≥ 38°C)

Không phổ biến: phản ứng tại chỗ khác bao gồm chai cứng, tê

Dữ liệu hậu marketing

Rối loạn hệ miễn dịch

Hiếm: phản ứng dị ứng (bao gồm các phản ứng phản vệ và á phản vệ), phù mạch.

Các rối loạn hệ thần kinh

Hiếm: ngất xỉu hoặc các cơn cường phế vị sau tiêm, đôi khi đi kèm với các cử động rung giật tăng trương lực

Thông báo cho bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc

4.9. Quá liều

Hiện chưa có đầy đủ số liệu.

5. Đặc tính dược học

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

GLAXOSMITHKLINE PTE LTD VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

17/12/17

5.1. Dược lực học

Mã ATC

Nhóm tác dụng dược lý: Vaccine Papillomavirus, J07BM02

Cơ chế tác dụng

Nhiễm dai dẳng các tuýp HPV gây ung thư là nguyên nhân của gần như toàn bộ các trường hợp ung thư cổ tử cung trên toàn cầu.

Cervarix là một vaccine tái tổ hợp không gây nhiễm được sản xuất từ các tiểu thể tương tự virus (VLPs) có độ tinh khiết cao với thành phần là protein vỏ chính L1 của HPV gây ung thư tuýp 16 và 18. Do VLPs không chứa ADN của virus nên không có khả năng gây nhiễm tế bào, tái sinh hay gây bệnh. Các nghiên cứu trên động vật đã chứng minh hiệu quả của vaccine L1 VLP chủ yếu là kích thích tạo ra đáp ứng miễn dịch dịch thể và trí nhớ miễn dịch qua trung gian tế bào.

Kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy Cervarix được bổ trợ với AS04 tạo ra đáp ứng miễn dịch kéo dài và cao hơn so với các kháng nguyên cùng loại chỉ được bổ trợ với tá dược là muối nhôm [$Al(OH)_3$].

Ung thư cổ tử cung xâm nhiễm bao gồm ung thư tế bào vảy cổ tử cung (84%) và ung thư biểu mô tuyến (16%, chiếm tới 20% ở các nước phát triển có triển khai chương trình khám tầm soát)

HPV-16 và HPV-18 là nguyên nhân của gần 70% các trường hợp ung thư cổ tử cung ở khắp các khu vực trên thế giới.

Các tuýp HPV gây ung thư khác (HPV-31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -66, -68) cũng có gây ung thư cổ tử cung. HPV-16, -18, -45, -31 là 4 tuýp thường gây ung thư tế bào vảy cổ tử cung (gần 76%) và ung thư biểu mô tuyến (gần 91%).

Bằng chứng về đáp ứng nhắc lại (trí nhớ miễn dịch)

Sử dụng liều thử thách trung bình khoảng 6.8 năm sau lần tiêm phòng đầu tiên tạo nên đáp ứng miễn dịch nhắc lại đối với HPV-16 và HPV-18 (xác định bằng phương pháp ELISA và phản ứng trung hòa dùng hạt giả virion) vào ngày thứ 7. Quan sát thấy hiệu giá kháng thể trung bình nhân sau khi tiêm liều nhắc lại một tháng vượt quá so thời điểm một tháng sau liệu trình tiêm chủng cơ bản.

Đáp ứng nhắc lại cũng quan sát thấy ở một số chủng liên quan HPV-31 và HPV-45 bằng phương pháp ELISA.

Tác dụng dược lực học

Hiệu quả phòng bệnh

Hiệu quả của Cervarix được đánh giá trong hai thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng (HPV-001/007 và HPV-008) với sự tham gia của tổng cộng 19.778 phụ nữ từ 15 đến 25 tuổi.

Thử nghiệm HPV-001/007 được tiến hành ở Bắc Mỹ và Mỹ La-tinh. Tiêu chuẩn lựa chọn vào nghiên cứu gồm: âm tính với ADN HPV gây ung thư (HPV-16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 và 68) khi xét nghiệm mẫu cổ tử cung, huyết thanh âm tính đối với kháng thể kháng HPV-16 và HPV-18 và tế bào học bình thường. Các đặc tính này đại diện cho một quần thể chưa phơi nhiễm với các tuýp HPV gây ung thư trước khi tiêm vaccine.

Thử nghiệm lâm sàng HPV-008 đã được tiến hành tại Bắc Mỹ, Mỹ La-tinh, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương và Úc. Trước khi tiêm vaccine, tiến hành lấy mẫu để xác định ADN của HPV gây ung thư (HPV-16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 và 68) và kháng thể kháng HPV-16 và HPV-18 trong huyết thanh. Toàn bộ các phụ nữ đều được tiêm vaccine không xét đến kết quả tế bào học và

CÔNG TY GLAXOSMITHKLINE PTE LTD
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

17/D17

huyết thanh ban đầu cũng như tình trạng ADN. Các đặc tính này đại diện cho quần thể bao gồm cả những phụ nữ đã hoặc đang phơi nhiễm với HPV.

Giống như bất kỳ thử nghiệm đánh giá hiệu quả phòng bệnh nào, các đối tượng nhiễm ban đầu với một tuýp HPV đặc trưng nào đó sẽ không được chọn để đánh giá hiệu quả đối với tuýp đó.

Trong cả hai thử nghiệm, các tổn thương dưới đây được đánh giá:

- CIN2+ (Tăng sinh nội biểu mô cổ tử cung độ 2 và các tổn thương ở mức độ cao hơn)
- CIN1+ (Tăng sinh nội biểu mô cổ tử cung độ 1 và các tổn thương ở mức độ cao hơn)
- Các bất thường về tế bào học bao gồm các tế bào vảy không điển hình ở mức độ không xác định (ASC-US), các tổn thương nội biểu mô vẩy ở mức độ thấp (LSIL), các tổn thương nội biểu mô vẩy ở mức độ cao (HSIL) và ASC-US có mức độ nghi ngờ cao (ASC-H).
- Nhiễm kéo dài 6 tháng được xác định khi có ít nhất 2 mẫu dương tính với cùng một tuýp HPV trong khoảng thời gian tối thiểu là 5 tháng.
- Nhiễm kéo dài 12 tháng được xác định khi có ít nhất 2 mẫu dương tính với cùng một tuýp HPV trong khoảng thời gian tối thiểu là 10 tháng.

Trong nghiên cứu HPV-008, các tổn thương dưới đây cũng được đánh giá:

- CIN3+ (Tăng sinh nội biểu mô cổ tử cung độ 3 và các tổn thương ở mức độ cao hơn)
- VIN1+ (Tăng sinh nội biểu mô âm hộ độ 1 và các tổn thương ở mức độ cao hơn)
- VaIN1+ (Tăng sinh nội biểu mô âm đạo độ 1 và các tổn thương ở mức độ cao hơn).

Tăng sinh nội biểu mô cổ tử cung (CIN) độ 2 và 3 (CIN2+) được sử dụng như một dấu hiệu chỉ điểm đối với ung thư cổ tử cung trong các thử nghiệm lâm sàng. Nhiễm virus kéo dài ít nhất 6 tháng cũng được coi là một dấu hiệu chỉ điểm đối với ung thư cổ tử cung. Cho dù CIN độ 1 không được xem là dấu hiệu chỉ điểm đối với ung thư cổ tử cung nhưng các thương tổn này vẫn cần phải được theo dõi về mặt y tế.

1. Hiệu quả của vaccine ngừa HPV-16/18 ở các phụ nữ chưa phơi nhiễm với các tuýp HPV gây ung thư (nghiên cứu HPV-001/007)

Kết quả về hiệu quả đối với các thương tổn về mô bệnh học có liên quan đến HPV-16 hoặc HPV-18 (HPV-16/18) được chứng minh trong nghiên cứu HPV-001/007 (Đoàn hệ toàn bộ đối tượng nghiên cứu nghĩa là n các phụ nữ được tiêm ít nhất một liều vaccine) trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1. Hiệu quả vaccine ngừa CIN2+ và CIN1+ có liên quan đến HPV-16/18

Tổn thương liên quan HPV-16/18	Cervarix N = 481	Đối chứng (Muối nhôm) N = 470	% Hiệu quả (95% CI)
	Số các trường hợp		
CIN2+	0	9	100% (51,3; 100)
CIN1+	0	15	100% (73,4; 100)

Hiệu quả phòng ngừa các bất thường về tế bào học do HPV-16/18 là 96,7% (95% CI: 87,3; 99,6).

17/1/17

Hiệu quả phòng ngừa nhiễm HPV-16/18 kéo dài ở thời điểm được xác định sau 6 tháng và 12 tháng lần lượt là 98,2% (95% CI:89,5; 100) và 96,9% (95% CI: 81,4; 99,9).

Trong nghiên cứu HPV-001/007, các phụ nữ được tiếp tục theo dõi về hiệu quả bảo vệ của vaccine cho tới 6,4 năm (gần 77 tháng) sau mũi tiêm đầu tiên. Mặc dù bằng chứng cho thấy có sự tiếp tục phơi nhiễm như quan sát thấy ở nhóm đối chứng, không có bằng chứng nào cho thấy giảm mức độ bảo vệ ở nhóm phụ nữ tiêm vaccine.

2. Hiệu quả của vaccine ở các phụ nữ đã hoặc đang nhiễm HPV (nghiên cứu HPV-008)

Trong nghiên cứu HPV-008, các phân tích ban đầu về hiệu quả được tiến hành trên đoàn hệ tuân thủ đúng theo đề cương (đoàn hệ ATP: bao gồm các phụ nữ tiêm 3 mũi vaccine và không nhiễm các tuýp HPV được đánh giá vào thời điểm 0 và 6 tháng) và trên đoàn hệ được tiêm vaccine - 1 (nhóm TVC-1: bao gồm tất cả các phụ nữ đã tiêm ít nhất một mũi vaccine và không nhiễm các tuýp HPV được đánh giá vào thời điểm 0 tháng. Cả hai đoàn hệ này đều bao gồm cả các phụ nữ có xét nghiệm tế bào học bình thường hoặc tổn thương ở mức độ thấp và chỉ loại trừ các phụ nữ có tổn thương tế bào học ở mức độ cao (0,5%).

Thêm vào đó, các phân tích hiệu quả được thực hiện trên đoàn hệ được tiếm vắc xin rộng hơn (đoàn hệ TVC, bao gồm toàn bộ các phụ nữ đã được tiêm vaccine) và đoàn hệ TVC-không phơi nhiễm (TVC-naive, bao gồm toàn bộ phụ nữ đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine có tế bào bình thường, xét nghiệm HPV DNA âm tính đối với 14 tuýp HPV gây ung thư và có xét nghiệm huyết thanh ban đầu âm tính đối với HPV-16 và HPV-18).

2.1. Tóm tắt kết quả về hiệu quả

Trong nghiên cứu HPV-008, hiệu quả của vaccine ngừa HPV-16/18 có ý nghĩa thống kê đã được chứng minh trên đoàn hệ ATP và đoàn hệ TVC-1 đối với các tổn thương dưới đây (Xem phần 2.2.1 để thấy các kết quả hiệu quả chi tiết):

- Tổn thương về mô học:
  - CIN2+ và CIN1+ (Bảng 2 và 3)
    Thêm vào đó, hiệu quả vaccine ngừa CIN2+ có ý nghĩa thống kê được chứng minh đối với từng tuýp HPV-16 và HPV-18 riêng rẽ.
- Tổn thương về virus học và tế bào học
  - Nhiễm kéo dài 6 tháng và 12 tháng. (Bảng 4)
  - Bất thường tế bào học (≥ASCUS). (Bảng 4)
- Tổn thương tại âm hộ và âm đạo
  - VIN1+ hoặc ValN1+

Đồng thời với hiệu quả vaccine ngừa HPV-16 và HPV-18, các kết quả dưới đây đã được chứng minh trong nghiên cứu HPV-008:

- Hiệu quả vaccine ngừa CIN3+, CIN2+ và CIN1+ không tính đến tuýp ADN của HPV trong tổn thương và không tính đến tình trạng huyết thanh ban đầu đã được chứng minh trên đoàn hệ TVC và TVC- không phơi nhiễm . Trên các đoàn hệ này, Cervarix cũng cho hiệu quả giảm bớt liệu trình điều trị tại chỗ ở cổ tử cung. (Xem phần 2.2.2 để thấy các kết quả hiệu quả chi tiết)
- Hiệu quả vaccine ngừa các tuýp HPV gây ung thư không có trong vaccine cũng được chứng minh trên đoàn hệ ATP và TVC-1. (Xem phần 2.2.3 để thấy các kết quả hiệu quả chi tiết)

17/D17

2.2. Các kết quả chi tiết về hiệu quả

2.2.1. Hiệu quả bảo vệ ngừa HPV-16/18 ở các phụ nữ chưa phơi nhiễm với các tuýp HPV-16 và/hoặc HPV-18

Trong nghiên cứu HPV-008, gần 26% phụ nữ có dấu hiệu đang hoặc đã từng nhiễm HPV-16/18 và dưới 1% các phụ nữ có xét nghiệm HPV ADN ban đầu dương tính với cả hai tuýp HPV-16 và HPV-18.

Phân tích cuối cùng của nghiên cứu HPV-008 là phân tích dựa vào biến cố, nghĩa là được thực hiện khi có ít nhất 36 trường hợp CIN 2+ liên quan đến HPV16/18 xảy ra trong đoàn hệ ATP. Thời gian theo dõi trung bình trong nghiên cứu là khoảng 39 tháng sau liều đầu tiên.

Phân tích kết thúc nghiên cứu được thực hiện ở cuối quá trình theo dõi 4 năm (tức là 48 tháng sau liều đầu tiên) và bao gồm tất cả đối tượng nghiên cứu trong đoàn hệ TVC.

Bảng 2. Hiệu quả của vaccine ngừa CIN3+, CIN2+ và CIN1+ liên quan đến HPV-16/18- Phân tích đặc hiệu theo đề cương (ATP và TVC-1)

Tổn thương liên quan HPV 16/18		Phân tích nghiên cứu cuối cùng					Phân tích kết thúc nghiên cứu				
		Cervarix		Đối chứng		% Hiệu quả (96.1% CI)	Cervarix		Đối chứng		% Hiệu quả (95% CI)
		N	n	N	n		N	n	N	n	
CIN3+	ATP[1]	7344	2	7312	10	80.0% (0.3;98.1)	7338	2	7305	24	91.7% (66.6;99.1)
	TVC-1[2]	8040	2	8080	22	90.9% (60.8;99.1)	8068	2	8103	40	95.0% (80.7;99.4)
CIN2+	ATP[1]	7344	4	7312	56	92.9% (79.9;98.3)	7338	5	7305	97	94.9% (87.7;98.4)
	TVC-1[2]	8040	5	8080	91	94.5% (86.2;98.4)	8068	6	8103	135	95.6% (90.1;98.4)
CIN1+	ATP[1]	7344	8	7312	96	91.7% (82.4;96.7)	7338	12	7305	165	92.8% (87.1;96.4)
	TVC-1[2]	8040	11	8080	135	91.8% (84.5;96.2)	8068	15	8103	210	92.9% (88.0;96.1)

N = số lượng các đối tượng trong mỗi nhóm

n = số lượng các trường hợp có tổn thương

[1] tiêm 3 mũi vaccine, ADN âm tính, huyết thanh âm tính ở thời điểm 0tháng và ADN âm tính ở thời điểm 6 tháng với các tuýp HPV (HPV-16 và HPV-18)

[2] tiêm ít nhất một mũi vaccine, ADN âm tính, huyết thanh âm tính ở thời điểm tháng 0 với các tuýp HPV (HPV-16 và HPV-18)

Thêm vào đó, ở thời điểm của phân tích nghiên cứu cuối cùng, hiệu quả của vaccine có ý nghĩa thống kê ngừa CIN2+ liên quan đến từng tuýp HPV-16 và HPV-18 đã được thấy trong cả hai đoàn hệ khi phân tích đặc hiệu theo đề cương.

Các theo dõi sâu hơn xác định một số trường hợp CIN3+, CIN2+ và CIN1+ có nhiễm đa tuýp HPV gây ung thư trong tổn thương. Để phân biệt rõ giữa các tuýp HPV được xem là nguyên nhân có thể nhất đối với tổn thương và các tuýp HPV chỉ được xem là có liên quan tạm thời, việc phân định tuýp HPV đã được tiến hành (phân tích sâu). Phân định tuýp HPV là phát hiện thấy các tuýp HPV bằng phản ứng chuỗi polymerase (PCR) có mặt ít nhất ở một trong hai mẫu tế bào học kế tiếp nhau ngoài việc chỉ phát hiện được trong tổn thương. Dựa trên việc phân định tuýp HPV này, quá trình phân tích

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

17/AD17

thử nghiệm lâm sàng sẽ loại trừ đi các trường hợp CIN1+ và CIN2+ (trong nhóm tiêm vaccine và trong nhóm chứng) được xác định nguyên nhân không phải liên quan đến nhiễm HPV-16 và HPV-18 (xem bảng dưới)

Bảng 3: Hiệu quả vaccine ngừa CIN3+, CIN2+ và CIN1+ liên quan tới HPV-16/18 - phân định tuýp HPV (ATP và TVC-1)

Tổn thương liên quan HPV 16/18		Phân tích nghiên cứu cuối cùng					Phân tích kết thúc nghiên cứu				
		Cervarix		Đối chứng		% Hiệu quả (96.1% CI)	Cervarix		Đối chứng		% Hiệu quả (95% CI)
		N	n	N	n		N	n	N	n	
CIN3+	ATP[1]	7344	0	7312	8	100% (36.4; 100)	7338	0	7305	22	100% (81.8;100)
	TVC-1[2]	8040	0	8080	20	100% (78.1;100)	8068	0	8103	38	100% (89.8;100)
CIN2+	ATP[1]	7344	1	7312	53	98.1% (88.4;100)	7338	1	7305	92	98.9% (93.8;100)
	TVC-1[2]	8040	2	8080	87	97.7% (91.0;99.8)	8068	2	8103	128	98.4% (94.3;99.8)
CIN1+	ATP[1]	7344	2	7312	90	97.8% (91.4;99.8)	7338	3	7305	154	98.1% (94.3;99.6)
	TVC-1[2]	8040	5	8080	128	96.1% (90.3;98.8)	8068	6	8103	196	97.0% (93.3;98.9)

N = số lượng các đối tượng trong mỗi nhóm

n = số lượng các trường hợp có tổn thương

[1] tiêm 3 mũi vaccine, ADN âm tính, huyết thanh âm tính ở thời điểm 0 tháng và ADN âm tính ở thời điểm 6 tháng với các tuýp HPV (HPV-16 và HPV-18)

[2] tiêm ít nhất một mũi vaccine, ADN âm tính, huyết thanh âm tính ở thời điểm tháng 0 với các tuýp HPV (HPV-16 và HPV-18)

Ngoài ra, ở thời điểm phân tích nghiên cứu cuối cùng, hiệu quả của vaccine có ý nghĩa thống kê ngừa CIN2+ liên quan đến từng tuýp HPV-16 và HPV-18 đã được thấy trong cả hai đoàn hệ khi phân định tuýp HPV

GLAXOSMITHKLINE PTE LTD
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

17/D17

Bảng 4: Hiệu quả vaccine ngừa các tổn thương virus học và tế bào học liên quan đến HPV-16/18 (ATP và TVC-1)

Tổn thương liên quan HPV 16/18		Phân tích nghiên cứu cuối cùng					Phân tích kết thúc nghiên cứu				
		Cervarix		Đối chứng		% Hiệu quả (96.1% CI)	Cervarix		Đối chứng		% Hiệu quả (96.1% CI)
		N	n	N	n		N	n	N	n	
Tổn thương virus học											
Nhiễm kéo dài 6 tháng	ATP(1)	7177	29	7122	488	94.3% (91.5;96.3)	7182	35	7137	588	94.3% (92.0;96.1)
	TVC-1(2)	7941	67	7964	661	90.2% (87.3;92.6)	7976	73	7999	770	91.0% (88.5;93.0)
Nhiễm kéo dài 12 tháng	ATP(1)	7035	20	6984	227	91.4% (86.1;95.0)	7082	26	7038	354	92.9% (89.4;95.4)
	TVC-1(2)	7812	51	7823	340	85.3% (79.9;89.4)	7864	58	7880	478	88.2% (84.5;91.2)
Tổn thương tế bào học											
Bất thường về tế bào học (≥ASCUS)	ATP(1)	7340	48	7312	427	89.0% (84.9;92.1)	7334	55	7305	575	90.7% (87.8;93.1)
	TVC-1(2)	8040	75	8080	553	86.7% (82.8;89.8)	8068	84	8103	714	88.6% (85.6;91.0)

N = số lượng các đối tượng trong mỗi nhóm
n = số lượng các trường hợp có tổn thương
(1) tiêm 3 mũi vaccine, ADN âm tính, huyết thanh âm tính ở thời điểm 0 tháng và ADN âm tính ở thời điểm 6 tháng với các tuýp HPV (HPV-16 và HPV-18)
(2) tiêm ít nhất một mũi vaccine, ADN âm tính, huyết thanh âm tính ở thời điểm tháng 0 với các tuýp HPV (HPV-16 và HPV-18)

Ở thời điểm phân tích nghiên cứu cuối cùng, hiệu quả của vaccine có ý nghĩa thống kê ngừa VIN1+ hoặc VaIN1+ liên quan đến HPV-16/18 cũng được thấy ở cả hai đoàn hệ: 80,0% (96,1% CI: 0,3;98,1) ở đoàn hệ ATP và 83,2% (96,1% CI: 20,2;98,4) ở đoàn hệ TVC-1. Ở thời điểm phân tích kết thúc nghiên cứu, hiệu quả của vaccine chống lại VIN1+ hoặc VaIN1+ liên quan HPV16/18 là 75.1% (95% CI: 22.9;94.0) ở đoàn hệ ATP và 77.7% (95% CI: 32.4;94.5) ở đoàn hệ TVC-1.

Chưa có các bằng chứng về khả năng ngừa các bệnh gây ra bởi các tuýp HPV cho các đối tượng có ADN HPV dương tính khi vào nghiên cứu. Tuy nhiên, các đối tượng đã nhiễm một trong các tuýp HPV có trong vaccine trước khi tiêm phòng được bảo vệ khỏi các bệnh có căn nguyên bởi tuýp HPV khác.

2.2.2. Tác động tổng thể của vaccine đối với gánh nặng bệnh tật do HPV gây ra

Hiệu quả tổng thể của vaccine không xét đến tuýp ADN của HPV trong tổn thương và phân tầng dựa trên ADN HPV ban đầu và tình trạng huyết thanh được đánh giá trong nghiên cứu HPV-008.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

17/D17

Trong đoàn hệ TVC và TVC-không phơi nhiễm ~~non~~, bao gồm tất cả phụ nữ tiêm vaccine, hiệu quả của vaccine chống lại CIN3+, CIN2+ và CIN1+ được thể hiện trong bảng 5. Tác động của Cervarix làm giảm thiểu việc sử dụng các biện pháp điều trị cục bộ ở cổ tử cung (quy trình khoét chóp bằng vòng điện, cắt cổ tử cung Cone, dùng dao hoặc laser) cũng được đánh giá trên cùng đoàn hệ (Bảng 5).

Đoàn hệ TVC-không phơi nhiễm là nhóm nhỏ của TVC, bao gồm những phụ nữ có tế bào học bình thường, có ADN HPV âm tính đối với 14 tuýp HPV gây ung thư (HPV-16, -18, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -66, -68) và xét nghiệm huyết thanh ban đầu âm tính với HPV-16 và HPV-18.

Bảng 5. Hiệu quả của vaccine không xét đến tuýp ADN của HPV trong tổn thương, không xét đến tình trạng huyết thanh ban đầu

		Phân tích nghiên cứu cuối cùng					Phân tích kết thúc nghiên cứu				
		Cervarix		Đối chứng		% Hiệu quả (96.1% CI)	Cervarix		Đối chứng		% Hiệu quả (96.1% CI)
		N	n	N	n		N	n	N	n	
CIN3+	TVC-không phơi nhiễm [1]	5449	3	5436	23	87.0% (54.9;97.7)	5466	3	5452	44	93.2% (78.9;98.7)
	TVC [2]	8667	77	8682	116	33.4% (9.1;51.5)	8694	86	8708	158	45.6% (28.8;58.7)
CIN2+	TVC-không phơi nhiễm [1]	5449	33	5436	110	70.2% (54.7;80.9)	5466	61	5452	172	64.9% (52.7;74.2)
	TVC [2]	8667	224	8682	322	30.4% (16.4;42.1)	8694	287	8708	428	33.1% (22.2;42.6)
CIN1+	TVC -không phơi nhiễm [1]	5449	106	5436	211	50.1% (35.9;61.4)	5466	174	5452	346	50.3% (40.2;58.8)
	TVC [2]	8667	451	8682	577	21.7% (10.7;31.4)	8694	579	8708	798	27.7% (19.5;35.2)
Liệu pháp điều trị tại cổ tử cung	TVC -không phơi nhiễm [1]	5449	26	5436	83	68.8% (50.0;81.2)	5466	43	5452	143	70.2% (57.8;79.3)
	TVC [2]	8667	180	8682	240	24.7% (7.4;38.9)	8694	230	8708	344	33.2% (20.8;43.7)

N = Số đối tượng trong mỗi nhóm

n = Số lượng các trường hợp có tổn thương

[1] TVC -không phơi nhiễm: bao gồm tất cả các phụ nữ được chủng ngừa (ít nhất là một liều) có tế bào học bình thường, có ADN HPV âm tính đối với 14 tuýp HPV gây ung thư (HPV-16, -18, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -66, -68) và xét nghiệm huyết thanh ban đầu âm tính với HPV-16 và HPV-18.

[2] TVC: bao gồm tất cả những phụ nữ tiêm ít nhất 1 liều vaccine

GLAXOSMITHKLINE PTE LTD
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

17/D17

2.2.3 Hiệu quả phòng ngừa đối với lây nhiễm các tuýp HPV gây ung thư khác ngoài HPV-16 và HPV-18

Trong nghiên cứu HPV-008, hiệu quả của vaccine chống lại 12 tuýp HPV gây ung thư không có trong vaccine (HPV-31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -66, -68) được đánh giá trong đoàn hệ ATP và đoàn hệ TVC-1.

Hiệu quả của vaccine chống lại nhiễm kéo dài 6 tháng và CIN2+ liên quan những tuýp HPV gây ung thư đơn lẻ không có trong vaccine quan sát ở đoàn hệ ATP được thể hiện trong Bảng 6.

Bảng 6: Hiệu quả của vaccine chống lại các tuýp HPV gây ung thư không có trong vaccine trong nhiễm kéo dài 6 tháng và CIN2+ (đoàn hệ ATP)

Đoàn hệ ATP [1]						
Nhiễm kéo dài 6 tháng						
HPV tuýp	Phân tích nghiên cứu cuối cùng			Kết thúc phân tích nghiên cứu		
	Cervarix	Đối chứng	% Hiệu quả (96.1% CI)	Cervarix	Đối chứng	% Hiệu quả (96.1% CI)
	n	n		n	n	
Các tuýp liên quan HPV-16[2)]						
HPV-31	45	199	77.5% (68.3;84.4)	58	247	76.8% (69.0;82.9)
HPV-33	55	100	45.1% (21.7;61.9)	65	117	44.8% (24.6;59.9)
HPV-35	55	43	-28.4% (-100.3;17.2)	67	56	-19.8% (-74.1;17.2)
HPV-52	293	315	7.4% (-9.9;22.0)	346	374	8.3% (-6.5;21.0)
HPV-58	111	101	-10.3% (-48.0;17.7)	144	122	-18.3% (-51.8;7.7)
Các tuýp liên quan đến HPV-18[2]						
HPV-39	147	149	1.0% (-26.7;22.7)	175	184	4.8% (-17.7;23.1)
HPV-45	19	79	76.1% (59.1;86.7)	24	90	73.6% (58.1;83.9)
HPV-59	56	59	4.8% (-42.4;36.4)	73	68	-7.5% (-51.8;23.8)
HPV-68	138	134	-3.1% (-33.4;20.3)	165	169	2.6% (-21.5;21.9)
Các tuýp khác [2]						
HPV-51	304	354	14.5% (-0.8;27.4)	349	416	16.6% (3.6;27.9)
HPV-56	182	174	-5.0% (-31.5;16.1)	226	215	-5.3% (-27.5;13.1)
HPV-66	168	178	5.7% (-18.4;24.9)	211	215	2.3% (-18.7;19.6)
CIN2+						
HPV tuýp	Phân tích nghiên cứu cuối cùng			Kết thúc phân tích nghiên cứu		
	Cervarix	Đối chứng	% Hiệu quả (96.1% CI)	Cervarix	Đối chứng	% Hiệu quả (96.1% CI)

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

17/1/17

	n	n		n	n	
Tuýp liên quan HPV-16 [2]						
HPV-31	2	25	92.0% (66.0;99.2)	5	40	87.5% (68.3;96.1)
HPV-33	12	25	51.9% (-2.9;78.9)	13	41	68.3% (39.7;84.4)
HPV-35	1	6	83.3% (-49.1;99.7)	3	8	62.5% (-56.5;93.6)
HPV-52	12	14	14.3% (-108.1;65.4)	24	33	27.6% (-26.3;59.1)
HPV-58	6	17	64.5% (1.5;89.2)	15	21	28.5% (-45.5;65.7)
Tuýp liên quan HPV-18 [2]						
HPV-39	3	10	69.8% (-24.2;95.2)	4	16	74.9% (22.3;93.9)
HPV-45[3]	0	4	100% (-67.8;100)	2	11	81.9% (17.0;98.1)
HPV-59	1	4	74.9% (-178.6;99.6)	1	5	80.0% (-79.1;99.6)
HPV-68	5	11	54.4% (-49.8;88.4)	11	15	26.8% (-70.7;69.6)
Các tuýp khác [2]						
HPV-51	10	27	62.9% (18.0;84.7)	21	46	54.4% (22.0;74.2)
HPV-56	4	10	59.9% (-47.1;91.5)	7	13	46.1% (-45.2;81.8)
HPV-66	4	10	60.0% (-46.7;91.6)	7	16	56.4% (-12.1;84.8)

n = Số lượng các trường hợp
[1] tiêm 3 mũi vaccine, AND âm tính với các tuýp HPV tương ứng trong phân tích ở thời điểm tháng 0 và tháng 6.
[2] Các tuýp được liệt kê theo số thứ tự và không theo dữ liệu về dịch tễ học.
[3] Số các đối tượng bị CIN2+ liên quan HPV-45 mà ước tính hiệu quả của vaccine bị giới hạn.

Ở thời điểm phân tích nghiên cứu cuối cùng, hiệu quả bảo vệ của vaccine có ý nghĩa thống kê chống lại nhiễm kéo dài 6 tháng đã được quan sát đối với các tuýp HPV 31, 33, và 45 trong đoàn hệ ATP và các tuýptuýp HPV 31, 33, 45 và 51 trong đoàn hệ TVC-1. Hiệu quả đáng kể có ý nghĩa thống kê của vaccine chống lại CIN2+ đã được quan sát đối với các tuýp HPV 31, 51 và 58 trong đoàn hệ ATP và các tuýptuýp HPV 31, 33, 35 và 51 trong đoàn hệ TVC-1.

Ở thời điểm kết thúc phân tích nghiên cứu, nhiều trường hợp được quan sát thấy và giới hạn dưới trên giá trị 0 (95% CI) đối với các tuýp HPV 31, 33, 45 và 51 cho nhiễm kéo dài 6 tháng và CIN2+ trong cả đoàn hệ ATP và TVC-1. Đối với CIN2+, giới hạn dưới trên giá trị 0 (95% CI) đã được quan sát ở tuýp HPV 39 ở đoàn hệ ATP và tuýp HPV 66 ở đoàn hệ TVC-1.

Ở thời điểm phân tích nghiên cứu cuối cùng, hiệu quả đáng kể của vaccine chống lại CIN2+ đối với tất cả các tuýp HPV kết hợp (HPV-31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -66, -68) ngoại trừ tuýp HPV-16 và HPV-18 được thấy đạt 54.0% (96.1% CI: 34.0;68.4) trong đoàn hệ ATP và 46.0%

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

17/017

(96.1% CI: 27.0;60.3) trong đoàn hệ TVC-1. Ở thời điểm kết thúc phân tích nghiên cứu, hiệu quả của vaccine chống lại CIN2+ cho tất cả các tuýp HPV kết hợp ngoại trừ tuýp HPV 16 và HPV 18 là 46.8% (95% CI: 30.7;59.4) ở đoàn hệ ATP và 40.8% (95% CI: 25.5;53.1) ở đoàn hệ TVC-1.

Tính sinh miễn dịch của vaccine

Đáp ứng kháng thể đối với HPV-16 và HPV-18 được xác định bằng thử nghiệm ELISA đặc hiệu cho thấy có sự tương quan chặt chẽ với phản ứng trung hòa (Như phản ứng ddùng hạt giả virion do Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ phát triển). Sự thẩm thấu kháng thể từ huyết thanh ra dịch nhầy cổ tử cung đã được xác định trong các thử nghiệm lâm sàng.

Trong các thử nghiệm lâm sàng, 99% đối tượng huyết thanh âm tính ban đầu đã có chuyển đổi huyết thanh đối với cả 2 tuýp HPV-16 và 18 sau khi tiêm vaccine mũi thứ 3 một tháng. Hiệu giá trung bình nhân (GMT) kháng thể IgG tạo ra bởi vaccine cao hơn hiệu giá đo được ở các phụ nữ bị nhiễm HPV trước đó nhưng đã khỏi (nhiễm tự nhiên). Đối tượng có huyết thanh ban đầu dương tính và âm tính đều đạt được hiệu giá như nhau sau tiêm phòng vaccine.

Đáp ứng miễn dịch ở phụ nữ từ 15 đến 25 tuổi

Đáp ứng miễn dịch chống lại HPV-16 và HPV-18 được đánh giá cho tới thời điểm 76 tháng sau khi tiêm mũi vaccine đầu tiên trong nghiên cứu HPV-001/007 ở các phụ nữ từ 15 đến 25 tuổi tại thời điểm tiêm vaccine. Trong nghiên cứu HPV-23, đáp ứng miễn dịch tiếp tục được đánh giá tới thời điểm 8,4 năm (100,8 tháng) sau đợt tiêm phòng đầu tiên đối với một tập hợp con của đối tượng trong nghiên cứu HPV-001/007.

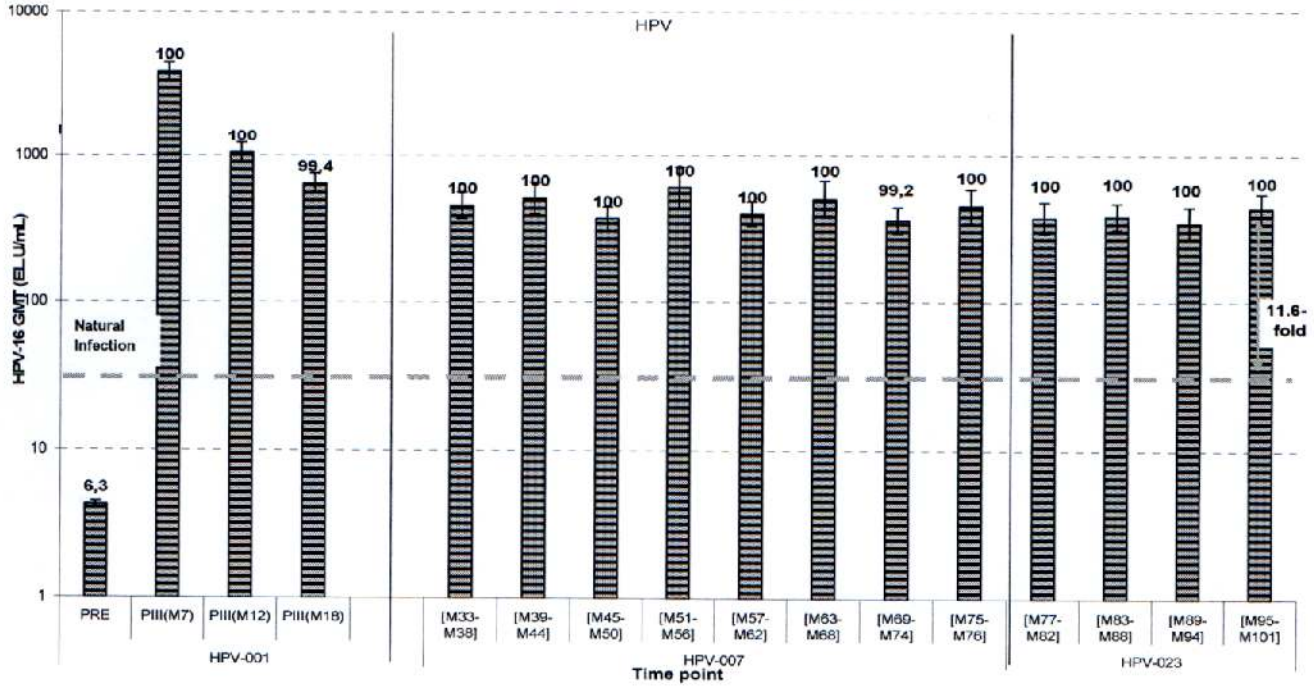
Trong nghiên cứu HPV-023, ≥ 100% phụ nữ dương tính với cả chủng HPV-16 và HPV-18 xác định bằng phương pháp ELISA hoặc phản ứng trung hòa dùng hạt giả virion (PBNA) tới thời điểm 8,4 năm sau đợt tiêm phòng đầu tiên.

Kết quả tính sinh miễn dịch từ nghiên cứu HPV-001/007/023 được trình bày trong các đồ thị dưới đây:

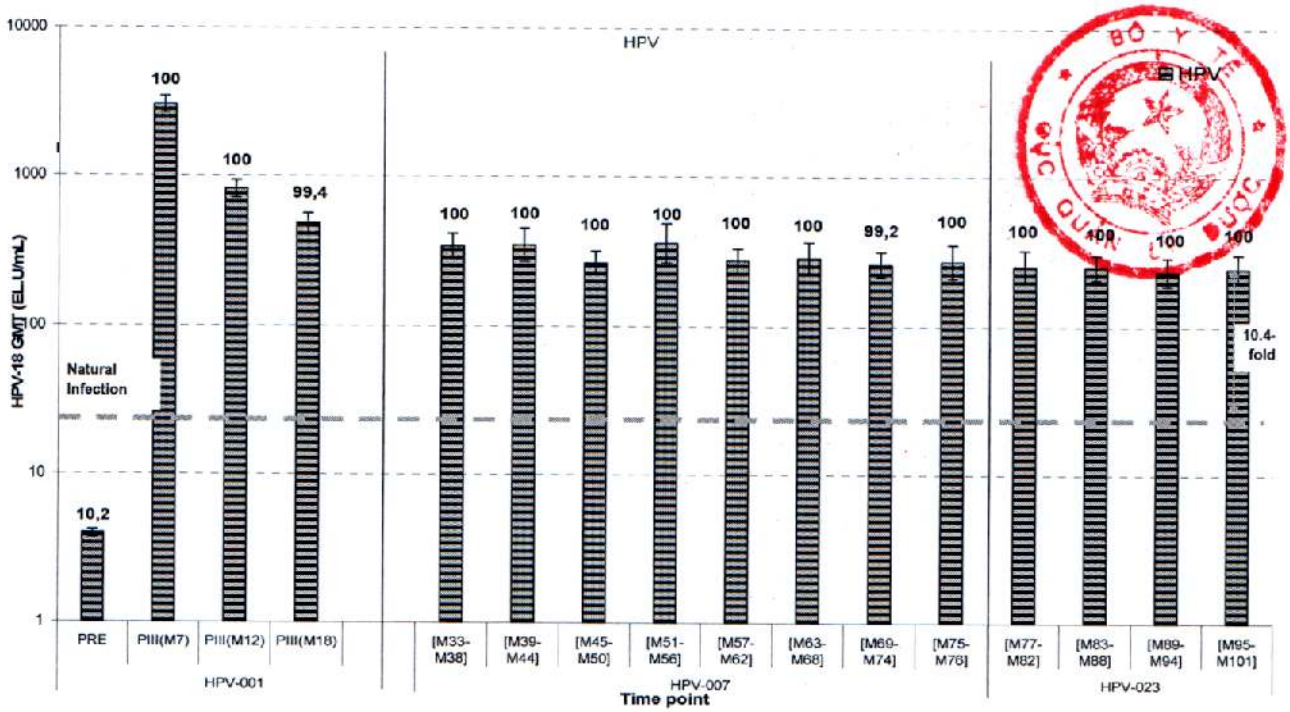
Diễn tiến của hiệu giá kháng thể trung bình nhân (GMTs) đối với IgG anti-HPV-16 trong nghiên cứu HPV-001, HPV-007 và HPV-023 (Nhóm ATP về tính sinh miễn dịch)

CÔNG TY GLAXOSMITHKLINE PTE LTD
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

17/10/17



Diễn tiến của hiệu giá kháng thể trung bình nhân (GMTs) đối với IgG anti-HPV-18 trong nghiên cứu HPV-001, HPV-007 và HPV-023 (Nhóm ATP về tính sinh miễn dịch)



Hiệu giá trung bình nhân (GMT) của IgG có được sau tiêm vaccine đối với cả 2 loại HPV-16 và HPV-18 đạt đỉnh vào tháng thứ 7 và sau đó giảm dần về đường nằm ngang từ tháng thứ 18 và không giảm đáng kể cho đến cuối của quá trình theo dõi (tháng thứ 101). Ở thời điểm tháng 101, GMT đối với cả 2 tuýp HPV-16 và HPV-18 vẫn cao hơn ít nhất 10 lần so với hiệu giá có được ở các phụ nữ từng

17/D17

nhiễm HPV trước đó nhưng hiện đã khỏi (nhiễm tự nhiên) và 100% phụ nữ có huyết thanh dương tính đối với cả 2 loại kháng nguyên.

Trong nghiên cứu HPV-008, đáp ứng miễn dịch tới tháng thứ 48 cũng tương tự với đáp ứng miễn dịch quan sát được trong nghiên cứu HPV-001/007. Diễn tiến về động học tương tư cũng được thấy đối với kháng thể trung hòa.

Bắc cầu hiệu quả của Cervarix ở phụ nữ từ 15 đến 25 tuổi cho các lứa tuổi 10-14 tuổi

Trong 2 thử nghiệm lâm sàng được tiến hành trên bé gái và thiếu niên từ 10-14 tuổi, tất cả các đối tượng nghiên cứu đều có chuyển đổi huyết thanh đối với cả 2 tuýp HPV-16 và HPV-18 sau mũi tiêm thứ 3 (tháng thứ 7) với GMT cao hơn ít nhất 2 lần so với các phụ nữ từ 15 đến 25 tuổi.

5.2. Đặc tính dược động học

Không yêu cầu đánh giá đặc tính dược động học đối với vaccine.

5.3. Nghiên cứu lâm sàng

Xem phần *"Đặc tính dược lực học"*

5.4. Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng

Tính sinh ung thư/gây đột biến

Chưa có nghiên cứu nào được thực hiện với Cervarix. Tuy nhiên, hệ thống chất bổ trợ MLP không sinh đột biến qua các thử nghiệm sinh đột biến chuẩn.

Độc tính học đối với hệ sinh sản

Những nghiên cứu trên động vật thực hiện với Cervarix ở chuột nhắt cái không cho thấy ảnh hưởng bất lợi trực tiếp hoặc gián tiếp đến khả năng sinh sản, thai kỳ, sự phát triển của phôi/bào thai, quá trình sinh đẻ hoặc sự phát triển sau khi sinh.

Độc tính và/hoặc dược lý học trên động vật

Các dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy vaccine không có tác hại nghiêm trọng đặc hiệu với người dựa trên các nghiên cứu tương đương về độc tính cấp tính và độc tính liều nhắc lại, mức độ dung nạp tại chỗ và tính an toàn dược học trên hệ tim mạch/hô hấp.

6. Đặc tính của thuốc

6.1. Danh sách tá dược:

Sodium chloride, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, nước pha tiêm.

6.2. Hạn dùng

48 tháng kể từ ngày sản xuất.

Khi bảo quản ở nhiệt độ đề nghị từ +2°C đến +8°C, hạn dùng của Cervarix là:

- 4 năm cho dạng đóng gói đơn liều (trong lọ hoặc trong bơm tiêm đóng sẵn)
- 3 năm cho dạng đóng gói đa liều (trong lọ)

Nên dùng Cervarix ngay sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh.

Tuy nhiên, các dữ liệu nghiên cứu độ ổn định cho thấy Cervarix dạng đóng gói đơn liều vẫn ổn định và có thể dùng được trong trường hợp vaccine được bảo quản bên ngoài tủ lạnh tới 3 ngày ở nhiệt độ từ 8°C đến 25°C hoặc tới 1 ngày ở nhiệt độ từ 25°C đến 37°C.

Nên sử dụng ngay sau khi mở lọ vaccine đa liều. Nếu không sử dụng ngay lập tức thì phải bảo quản vaccine trong tủ lạnh (2°C – 8°C). Loại bỏ vaccine nếu không sử dụng trong vòng 6 giờ sau khi mở.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

6.3. Thận trọng đặc biệt khi bảo quản

Bảo quản trong tủ lạnh (2°C-8°C).

Không để đông đá.

Giữ nguyên trong hộp để tránh ánh sáng.

6.4. Quy cách và đóng gói

Bơm tiêm đóng sẵn (thủy tinh loại I) chứa 0,5ml huyền dịch với pít tông có đáy bằng cao su (cao su butyl), có hoặc không có kim tiêm.

Lọ (thủy tinh loại I) chứa 0,5ml huyền dịch với nắp cao su (cao su butyl).

6.5. Tính tương kị

Chưa có các nghiên cứu về tính tương kị, không trộn lẫn vaccine này với các thuốc khác.

6.6. Hướng dẫn sử dụng, xử lý và hủy bỏ

Ở điều kiện bảo quản thấy có đám tủa trắng với phần nước nổi trong không màu trong bơm tiêm/lọ. Đây không phải là dấu hiệu vaccine bị hỏng.

Trước khi sử dụng, nên kiểm tra bơm tiêm/lọ bằng mắt thường trước và sau khi lắc để xem có bất kỳ phần tử lạ và/hoặc bất thường nào hay không. Loại bỏ vaccine nếu thấy bất thường.

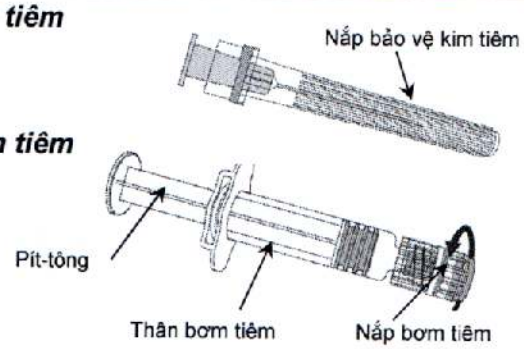
Nên lắc kỹ vaccine trước khi sử dụng.w

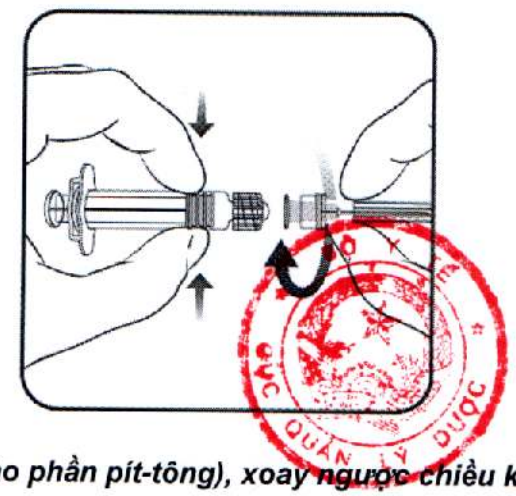
Nên dùng syringe và kim tiêm vô khuẩn để rút mỗi liều 0,5 ml trong lọ vaccine đa liều; Cần thận trọng để tránh nhiễm khuẩn các thành phần khác.

<u>Hướng dẫn sử dụng vaccine đóng sẵn trong bơm tiêm</u>

Kim tiêm

Bơm tiêm





1. Một tay giữ thân bơm tiêm (không giữ vào phần pít-tông), xoay ngược chiều kim đồng hồ để vặn nắp bơm tiêm

2. Đặt kim tiêm vào bơm tiêm và vặn theo chiều kim đồng hồ để gắn kim tiêm vào bơm tiêm (xem hình)

3. Bỏ nắp bảo vệ kim tiêm, đôi khi nắp này hơi cứng khi tháo bỏ

4. Tiêm vaccine

Loại bỏ sản phẩm không dùng hoặc chất thải theo yêu cầu của từng nước

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỸ

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

CÔNG TY GLAXOSMITHKLINE PTE LTD
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ

Sản xuất bởi
GlaxoSmithKline Biologicals SA.
89 Rue de L'Institute, BE-1330 Rixensart, Belgium.

Cervarix™ là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của GlaxoSmithKline group of companies
Dựa theo GDS phiên bản 16.0 ngày 18/02/2011
CER 0511-GDS16/180211

CÔNG TY GLAXOSMITHKLINE P.T.E LTD
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC